

图 2-10-3 特发性肺纤维化的胸部 HRCT 改变
胸部 HRCT 显示两肺外带胸膜下分布为主的斑片性网状模糊影，伴有蜂窝状改变。



2.治疗

（1）肺移植：最有效

一般剂量的乙酰半胱氨酸是祛痰药，高剂量乙酰半胱氨酸有抗氧化、抗纤维化的作用

（2）抗氧化、抗纤维化：尼达尼布、吡非尼酮、高剂量乙酰半胱氨酸（你 da 比你高）

姑息性治疗

（3）急性加重：

①**防控感染（但不推荐常规用）**特发性肺纤维化不是感染性疾病不需要预防使用抗生素，仅在因感染急性加重时用

②**高剂量激素（但不推荐常规用）**激素可以抗纤维化但长期使用激素副作用大，有不良反应（股骨头坏死）

③**氧疗（但不推荐机械通气）**弥散障碍影响 O_2 不会导致 CO_2 潴留

机械通气可以解决低氧血症和二氧化碳潴留

三、结节病

可能可能最可能：**双肺门淋巴结肿大（最常见）**，皮肤结节性红斑、冻疮样狼疮，葡萄膜炎

VS 原发性肺结核：肺内原发灶，结核性淋巴管炎，肺门淋巴结结核

硅肺“先进门”I期肺门淋巴结肿大

1.检查

①BALF：**CD4 T 细胞↑为主** CD4T细胞是规律 记特殊：CD8T细胞↑为主：ITP、再障、过敏性肺炎

②HRCT：**双肺门淋巴结肿大**，沿支气管血管束分布的结节

③**金标准活检**：**支气管镜见黏膜结节呈铺路石样，非干酪性肉芽肿** VS 结核：干酪性肉芽肿



图 2-10-5 结节病 I 期的胸部 X 线征象
36 岁病人，体检 X 线胸片发现双侧肺门淋巴结肿大，诊断结节病 I 期。

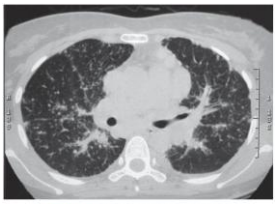
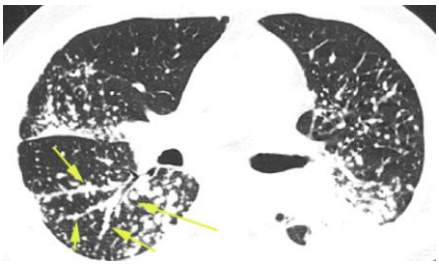


图 2-10-6 结节病的胸部 HRCT 表现
显示许多微小结节沿淋巴管走行，位于支气管血管旁间质、小叶间隔和胸膜下。纵隔和肺门淋巴结肿大。



2.**多无需治疗**。症状严重：糖皮质**激素**（6-24 月）师姐 10-4=6

特发性肺纤维化治不好、结节病多不用治——那把你的肺给我吧

3.**分期**

I：双肺门淋巴结肿大

II：双肺门淋巴结肿大、肺部浸润影 病变向肺部扩展

III：肺部浸润影

IV：蜂窝肺、肺纤维化、肺气肿（破坏修复代偿的表现）类似硅肺并发症

被破坏的肺组织通气减弱，其他地方就会有代偿性的肺气肿